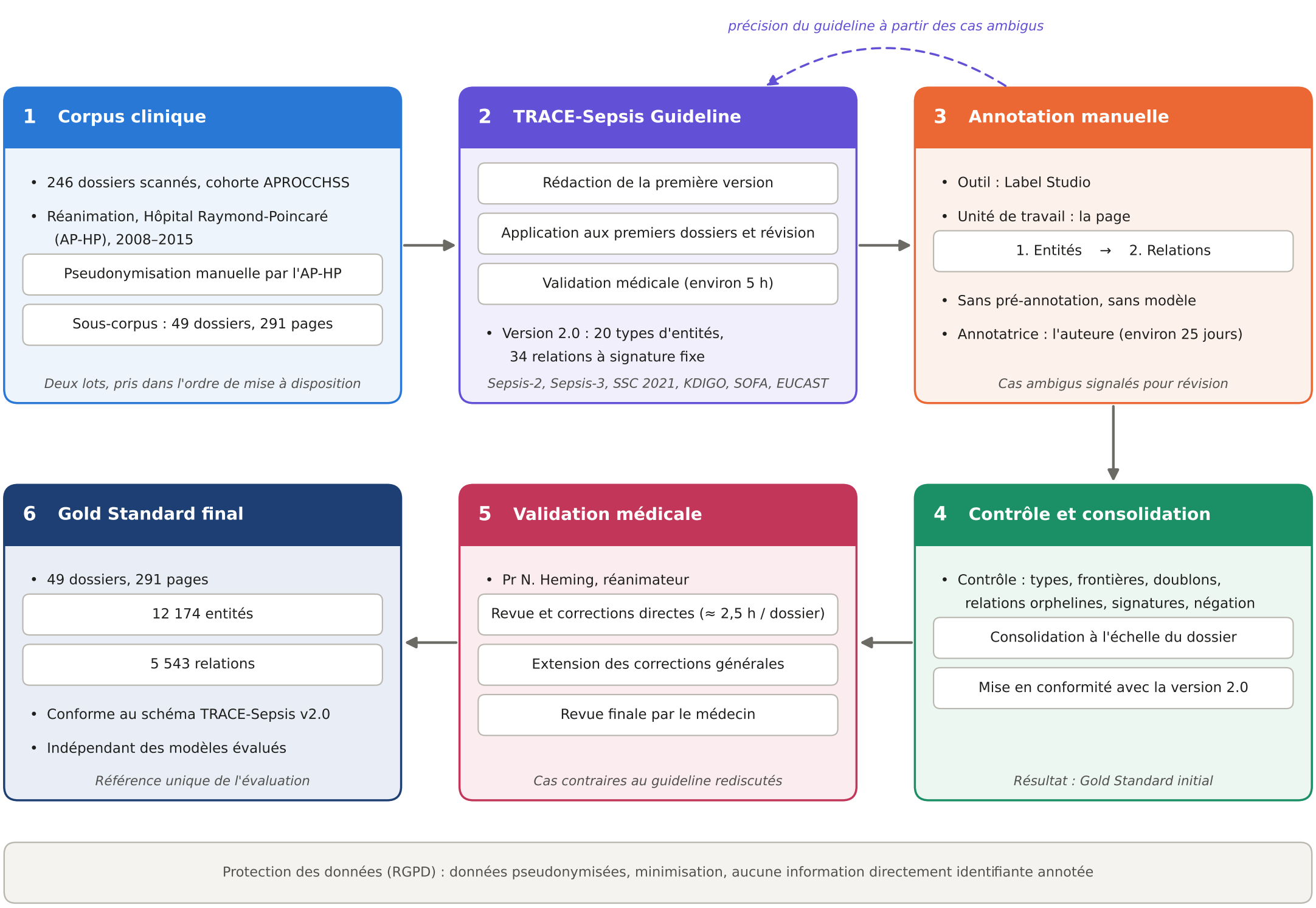

précision du guideline à partir des cas ambigus
1 Corpus clinique
• 246 dossiers scannés, cohorte APROCCHSS
• Réanimation, Hôpital Raymond-Poincaré (AP-HP), 2008–2015
Pseudonymisation manuelle par l'AP-HP
Sous-corpus : 49 dossiers, 291 pages
Deux lots, pris dans l'ordre de mise à disposition
2 TRACE-Sepsis Guideline
Rédaction de la première version
Application aux premiers dossiers et révision
Validation médicale (environ 5 h)
• Version 2.0 : 20 types d'entités, 34 relations à signature fixe
Sepsis-2, Sepsis-3, SSC 2021, KDIGO, SOFA, EUCAST
3 Annotation manuelle
• Outil : Label Studio
• Unité de travail : la page
1. Entités → 2. Relations
• Sans pré-annotation, sans modèle
• Annotatrice : l'auteure (environ 25 jours)
Cas ambigus signalés pour révision
4 Contrôle et consolidation
• Contrôle : types, frontières, doublons, relations orphelines, signatures, négation
Consolidation à l'échelle du dossier
Mise en conformité avec la version 2.0
Résultat : Gold Standard initial
5 Validation médicale
• Pr N. Heming, réanimateur
Revue et corrections directes (≈ 2,5 h / dossier)
Extension des corrections générales
Revue finale par le médecin
Cas contraires au guideline rediscutés
6 Gold Standard final
• 49 dossiers, 291 pages
12 174 entités
5 543 relations
• Conforme au schéma TRACE-Sepsis v2.0
• Indépendant des modèles évalués
Référence unique de l'évaluation
Protection des données (RGPD) : données pseudonymisées, minimisation, aucune information directement identifiante annotée